

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- 1 CML・骨髄腫の経口薬の服用時点(空腹時等)と残薬の管理
- 2 抗ウイルス薬・ST合剤・抗血栓薬など予防投与の継続確認
- 3 市販の胃薬・サプリ・グレープフルーツの確認
- 4 電話フォローで発熱・むくみ・息切れ・足の腫れを確認
- 5 症状をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ

病院と共有する情報

病型・レジメン・投与歴
(お薬手帳)

検査値

(HBV-DNA・好中球数)

副作用のGrade
(トレーシングレポート)

予防投与の服用状況
(電話フォローの結果)

病院薬剤師

- 1 病型・レジメンの監査、HBV検査と予防投与の計画
- 2 アントラサイクリン累積量・前投薬・腫瘍崩壊症候群対策
- 3 CAR-T・二重特異性抗体のCRS/ICANSへの院内対応
- 4 レナリドミド等の適正管理手順(RevMate)の運用
- 5 お薬手帳へのレジメン情報・投与歴の記載

2 主なレジメン・経口薬と薬局での確認ポイント

R-CHOP

点滴+経口

リツキシマブ+シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン(1日目)+プレドニゾン(1~5日目内服)

3週毎

✓ B型肝炎検査 ✓ プレドニゾンの服用日・高血糖 ✓ ビンクリスチンの便秘 ✓ 心毒性

イマチニブ

経口

400mg 1日1回 食後 連日内服

連日

✓ 浮腫・体重増加 ✓ 筋けいれん ✓ CYP3A4相互作用

ダサチニブ

経口

ダサチニブ 1日1回/ニロチニブ 1日2回(空腹時:食事の1時間以上前または食後2時間以降)

連日

✓ 胸水(ダサチニブ) ✓ QT延長・高血糖(ニロチニブ) ✓ 胃酸分泌抑制薬の併用

レナリドミド
+デキサメタゾン

点滴+経口

レナリドミド 1~21日目内服+デキサメタゾン 週1回(土ダラツムマブ)

4週毎

✓ 適正管理手順(RevMate)・避妊 ✓ 血栓予防薬 ✓ 腎機能で用量調整

ボルテゾミブ

点滴・注射

皮下注 週1~2回(レジメンにより異なる)

3~5週毎

✓ 末梢神経障害 ✓ 帯状疱疹予防(アシクロビル等) ✓ 起立性低血圧

● 経口 ● 点滴・注射 ● 点滴+経口 経口薬は保険薬局で交付:服用日・休業日と自宅での副作用を確認

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	レナリドミド・ボマリドミド 催奇形性	既往・疾患 妊娠・妊娠の可能性	胎児への重篤な影響	RevMateの手順と避妊の継続を確認
注意 添付文書 併用注意	ダサチニブ 胃内pH上昇で吸収低下	処方薬 市販薬 PPI・H2ブロッカー(市販の胃薬も)	血中濃度↓ → 効果減弱	市販の胃薬も確認、服用時間を調整
注意 添付文書 用法・用量	ニロチニブ 食事で吸収が増加	生活習慣 食事と一緒に服用	血中濃度↑ → QT延長等	食事の1時間以上前か食後2時間以降に服用
注意 添付文書 併用注意	イマチニブ・ボルテゾミブ等 CYP3A4阻害	処方薬 サプリ・食品 アゾール系抗真菌薬(感染予防)・グレープフルーツ	血中濃度↑ → 副作用↑	抗真菌薬の開始・変更と食品を確認
注意 添付文書 警告	抗CD20抗体 免疫抑制	既往・疾患 HBs抗原陽性・HBc抗体陽性	B型肝炎の再活性化	HBV-DNAのモニタリング予定を確認
確認 服薬指導上の注意	血液がんの治療中 発熱を隠す	市販薬 市販の解熱鎮痛薬・かぜ薬	感染症の発見の遅れ	服用前に体温を測り、発熱時は連絡

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

① 治療開始前	② 投与当日~1週	③ 投与後1~2週	④ 長期服用中
“B型肝炎の検査結果を確認してください。治療中や治療後にウイルスが再び増えることがあります” ✓ 薬局で確認 お薬手帳で病型・レジメン・HBV検査の結果、併用薬(CYP3A4・胃薬) △ ここに注意 HBV-DNAの定期測定の前を確認	“点滴中や当日の夜に、寒気・発熱・発疹が出る可能性があります。我慢せずすぐに伝えてください” ✓ 薬局で確認 前投薬の服用、CAR-T後の連絡先と治療施設の把握 △ ここに注意 CAR-T後は発熱・意識の変化で至急連絡、運転は控える	“37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずに、すぐ病院へ連絡してください” ✓ 薬局で確認 電話フォローで発熱、帯状疱疹予防薬・ST合剤の服用を確認 △ ここに注意 発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診	“毎日の服用が効果を保つ鍵です。むくみや息苦しさ、足の腫れなど気になる変化はありませんか” ✓ 薬局で確認 TKIの服薬継続・残薬、むくみ・息切れ・足の腫れ △ ここに注意 片足の腫れ・急な息切れは血栓症を疑い至急受診